10.6 화재안전 관리활동			
규 정 번 호	10.6	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	10.6 화재안전 관리활동	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	시설팀	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1.화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 2.소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 3.건축법 및 동법 시행령 4.의료법 시행규칙 제34조 별표 4 (의료기관의 시설규격) 5.피난기구의 화재안전성능기준(NFPC 301) / 인명구조기구의 화재안전성능기준(NFPC 302) 6.유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) / 비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304)		

▣ 목적 (Purpose)

환자와 직원을 화재로부터 보호하며 인화성 위험물질 등을 관리하여 화재 예방, 조기탐지와 진압, 화재발생 시 초기대응, 안전한 대피로 확보 및 안전한 의료서비스 환경을 제공하기 위함이다.

▣ 정책 (Policy)

1. 화재안전 관리에 대한 규정이 있다.
2. 화재안전 관리 계획이 있다.
3. 화재예방점검을 수행하고 안전하게 관리한다.
4. 소방훈련을 실시한다.
5. 소방안전 교육을 시행한다.
6. 직원은 화재 발생 시 대응체계를 알고 있다.
7. 금연관리에 대한 규정이 있다.
8. 금연관리를 수행한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 화재안전 관리 계획 수립

가. 화재안전 관리 계획의 내용 : 화재안전을 위한 예방점검, 소방교육, 소방훈련 등

나. 차기 년도 화재안전 관리 계획은 시행시기와 예산을 포함하여 당해 연도 12월에 수립하여 병원장의 결재를 득한 후 직원에게 공지하고 차기년도 1월부터 수행한다.

2. 화재예방점검 및 안전관리

가. 화재예방점검 : 법정점검(종합점검, 작동점검), 자가점검

1) 법정점검(종합점검, 작동점검)

가) 소방시설 작동기능점검 : 연 1회(매년 2월) 실시 후 결과를 병원장에게 보고 후 법정 기한 내에 소방서에 결과 보고서를 제출한다.

나) 소방시설 종합정밀점검 : 연 1회(매년 8월) 실시 후 결과를 병원장에게 보고 후 법정 기한 내에 소방서에 결과보고서를 제출한다.

구분	대상	점검 방법	횟수	시기
작동 기능 점검	특정소방대상물	소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검 (자체적으로 실시 가능)	1/년	종합정밀점검대상인 경우 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시
종합 정밀 점검	S/P설비 또는 물분무 등 설비가 설치된 대상	작동기능점검 검사내용 소방시설 등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법적 기준에 적합인지 여부를 점검(외부검사업체에 의뢰)	1/년	건축물 사용승인일이 속하는 달의 말일 까지

2) 자가점검

가) 소방시설, 피난시설, 방화시설 일일 점검 : 결과를 소방안전관리일지에 작성, 보관한다.

나) 소방시설 외관 점검 : 월 1회(매월 첫 번째 월요일)실시 후 결과를 매월 말일에 병원장에게 보고한다.

3) 소방시설 점검결과 자체 보수가 불가능 할 경우 즉시 전문 업체에 의뢰하여 보수한다.

<자가점검점검내용>

구분		점검주기	
		일	월
소화설비	소화기		●
	옥내외소화전		●
	스프링클러	●	
경보설비	자동화재 탐지설비	●	
	자동화재 속보설비	●	
	비상방송설비	●	
	비상경보설비	●	
	시각경보기	●	
	가스누설경보기	●	
	통합감시시설	●	
피난구조설비	유도등 피난구유도등통로유도등유도표지	●	
소화용수설비	상수도 소화용수설비	●	
	소화수조	●	
소화활동설비	연결송수관 설비	●	
	제연설비	●	
	비상콘센트 설비	●	
대피로(피난경로) 점검		●	
비상구 점검		●	
피난 안내도		●	
출입문 자동개폐장치		●	

4) 각 층과 각 병실에는 피난안내도를 부착하여 화재 시 대피가 용이 하도록 하며 미 부착여부와 구조변경, 시설물 설치 등으로 피난 안내 경로가 변경 될 때마다 피난 안내도를 변경하여 관리한다.
5) 각 층의 양쪽 복도의 계단은 피난층(지상1층)으로 연결되는 직통계단(피난계단)으로 계단에는 물건 적치 등으로 피난에 방해가 되지 않도록 상시 대피로를 확보한다.
6) 대피로(피난경로)는 소방안전관리자 또는 소방안전관리보조자가 순찰을 통하여 유도등 점등 상태, 불필요한 장애물 유무 등을 점검하여 피난경로를 확보한다.
7) 비상구는 소방안전관리자 또는 소방안전관리보조자는 순찰을 통하여 점검하여 비상구 주위에 물건 적치 또는 장애물 설치행위, 비상구 유도등 점등 등을 확인하며 외부로 통하는 출입구에는 화재 등 비상시에 자동으로 열릴 수 있도록 비상문 자동개폐장치를 설치·유지한다. (의료법 시행규칙 제34조 별표 4)
8) 방화문 관리
가) 방화문의 위치는 복도 양쪽 피난계단 출입구에 위치한다.
나) 본원 내에 설치된 방화문 주위에는 적재물이 놓여 있지 않아야 되며, 화재 시 닫힐 수 있는 구조로 설치되어야 한다.
9) 방화스크린 관리
가) 방화스크린 위치는 소방계획서를 참조한다.
나) 본원 내에 설치된 방화스크린 주위에는 적재물이 놓여 있지 않아야되며, 화재시 연동제어기가 작동하여 방화스크린이 자동으로 내려올 수 있는 구조로 설치되어야 한다.
다) 방화스크린은 화재 시 연기가 새어나오지 않는 구조여야 한다.

나. 예방점검 결과에 따른 유지 및 개선활동

1) 소방시설 점검 후 결과에 따라 문제점 및 개선사항을 보완 정비한다.
2) 소방안전 관리자는 유지 및 개선활동 후 그 결과를 원무과장에게 제출한다.
가) 점검결과 이상이 있을 시, 소방안전 관리자는 확인 후 보완조치를 취한다.
나) 점검결과 자체적인 조치가 불가능한 경우, 후속조치 및 보완사항은 병원운영위원회에서 심의·의결한다.
3) 법정점검 결과에 따른 유지 및 개선활동
가) 대행업체는 종합정밀점검 및 작동기능점검 실시 후, 점검인력 배치상황 및 점검결과를 소방안전 관리자에게 보고, 소방안전 관리자는 지적사항 조치완료 후 관할소방서에 제출한다.
나) 소방안전 관리자는 자가점검, 법정점검 후 지적사항을 보완/정비하고 결과를 병원장에게 보고한다.

다. 소방안전 관리자 및 소방안전관리보조자의 지정 및 업무

1) 자격 및 지정
가) 『화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률』 제24조에 의거 소방안전관리자 및 보조자를 선임한 날로부터 14일 이내에 관할 소방서장에게 그 사실을 신고하여야 한다.
나) 소방안전관리자 : 시설팀장
다) 소방안전관리보조자 : 원무과장
2) 업무
가) 본원의 소방안전관리자는 법적 선임자로서 『화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률』 제24조에 의거 다음의 업무를 수행하며, 소방안전관리보조자는 이를 보조한다.
(1) 소방계획서의 작성 및 시행
(2) 자위소방대 및 초기대응체계의 구성 · 운영 · 교육
(3) 피난시설 · 방화계획 및 방화시설의 유지 · 관리
(4) 소방훈련 및 교육의 계획과 시행

(5) 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 유지 · 관리
(6) 원내화기 단속 및 화재예방
(7) 화기취급의 감독 및 승인
(8) 기타 소방안전관리에 필요한 사항
(9) 소방시설물을 점검주기에 따라 소방시설 점검일지에 기록하고 보관한다.

나) 소방안전관리보조자는 소방안전관리자의 업무를 보조한다.

3. 소방 훈련 및 소방 안전 교육

가. 소방훈련은 가상의 상황을 시나리오로 구성하여 신고, 소화, 피난 등을 직접 수행하면서 훈련 하는 것을 의미하며, 소방안전 교육과 다르므로 소방훈련과 소방안전 교육은 각각 시행한다.

나. 소방훈련

1) 최소 연 1회 이상 실시한다.
2) 소방훈련의 내용으로는 소방안전 교육 내용(소화, 화재통보, 피난 등의 요령에 관한 사항, 화재 발생 시 대응체계)을 반영한 가상의 시나리오를 구성하여 직접 수행한다.
3) 훈련 결과에 대한 결과를 보관한다.

다. 소방교육

1) 최소 연 1회 이상 실시한다.
2) 교육 결과에 대한 자체 평가를 하여 보관한다.
3) 교육내용

가) 소화, 화재통보, 피난 등의 요령 및 화재 발생 시 대응 체계
(1) 소방시설, 장비의 사용방법, 화재초기대응 소방용품의 비치 및 사용방법 등
(2) 환자(보호(의무)자))의 대처요령 안내 – 게시판, 입원생활안내문 활용
(3) 신고절차(내선 900, 119)
(4) 피난층 위치
(5) 안전구획 위치
(6) 피난시설의 위치와 피난경로 설정
(7) 화재 시 폐쇄된 옥상 등의 출입문 관리 방법
(8) 직원의 업무분담, 환자 및 직원 등의 대피 장소에 대한 배치, 환자유형별 대피 계획 및 환자 후송, 산소 등 의료가스의 안전한 보관 및 취급 방법

4. 소화, 화재통보, 피난 등의 요령

가. 화재발생 시 행동요령(신고절차 등)

1) 환자(보호(의무)자)의 대처요령은 게시판과 입원생활 안내문을 통하여 안내한다.
2) 원내 화재를 목격한 직원은 "불이야" 외치기만 하여 혼란을 초래하는 행동을 하지 않고, 아래와 같이 대응한다.
3) 행동요령

행 동 요 령	1인 근무	2인 근무	3인 이상
상황전파: "00호실 불났어요", "00호 복도에 불났어요"와 같이 불이 난 곳을 분명하게 알려 불이 없는 곳으로 피난할 수 있도록 한다.	최초 화재발견자	최초 화재발견자	최초 화재발견자
비상연락/경보 가.병원스태프 (간호사 등) : 원무과(내선900)에 화재사실 연락 나.병원스태프 외 (간병사 등) : 소화전의 발신기 누름스위치를 누른다.	간호사, 간병사	선임간호사, 간병사	선임간호사, 간병사
피난유도 : 간병사에게 피난 안내를 요청하고 양측 피난 계단으로 대피를 유도한다.	간호사	간호사	간호사 A
초기진화: 소규모 화재는 소화기 및 옥내소화전을 이용해 즉시 진화를 시도한다.	간호사, 간병사	선임간호사, 간병사	간호사 B, 간병사

가) 옥내소화전 사용시에는 화재종류가 유류화재, 전기화재가 아닌지 먼저 확인하고, 부상방지를 위해 되도록 2인 1조로 실시하며, 소방호스 꼬임방지 및 원활한 소화수 공급을 위해 가급적 화재현장 반대쪽 소화전을 이용한다.

나) 화재규모가 클 경우 무리하게 진화를 시도하지 않고 즉시 119에 신고하고, 직원들은 환자들이 모두 안전한 지대로 신속하게 이동할 수 있도록 피난활동에 집중한다.

나. 비상 방송

1) 화재신고를 받은 원무과 직원은 원내방송을 시행한다.

2) 화재시 코드는 "(사이렌) 코드레드, 코드레드, 3층 306호 병실 화재 발생, 3층 306호 병실 화재 발생. 자위소방대는 즉시 화재 현장으로 출동 바람. 자위소방대는 즉시 화재 현장으로 출동 바람. 간병사 및 보호자분들은 의료진의 안내에 따라 환자분들이 화재 반대편 피난계단을 통해 지상 1층으로 대피하실 수 있도록 안내 및 도움을 주시기 바랍니다"

다. 화재 발생 시 대응체계

1) 자위소방대의 편성

가) 주간, 야간 및 휴일로 편성 운영한다.

나) 자위소방대장 등의 임무

(1) 대장은 자위소방대의 모든 지휘, 명령 등의 총 권한을 가진다.
(야간 및 휴일에는 당직 의사가 지휘, 명령 등의 총 권한을 가진다.)

(2) 부대장은 분대별 지휘, 감독을 하며 대장 부재 시 그 해야 할 일을 대행한다.

(3) 각 팀장은 담당 팀원의 지휘, 감독 임무를 수행한다.

5. 피난 계획

가. 일반적인 피난경로

*화재발생 장소 반대편 방향으로 이동한다.
*병실 → 복도(1차) → 양쪽 계단(2차) → 아래층 화재시 → 9층(옥상)으로 대피
*병실 → 복도(1차) → 양쪽 계단(2차) → 위층 화재시 → 지상1층(피난층)외부로 대피

나. 안전구획 및 대피공간(휴게공간)의 위치와 활용

1) 1차 안전구획(복도) : 수평방향의 피난 경로로 인접한 피난계단 또는 피난기구 방향에 위치한다.

2) 2차 안전구획(양측 피난계단) : 수직방향의 피난 경로로, 방화문으로 구획 된 양쪽 복도 끝 계단실이다.

3) 층별 대피공간(2층~8층 간호스테이션 우측 휴게공간) : 2층~8층 각 층 간호스테이션 우측 의 휴게공간은 화재 시 연동제어기에 의해 방화스크린이 내려와 화염과 연기를 차단하는 임시 안전구획(대피공간)이다. 해당 휴게공간은 방화스크린이 닫히면 내부에서 계단으로 연결되는 별도 출구가 없고, 외부 창문(소방관 진입창)을 통해 소방관이 진입하여 인명을 구조하는 공간이다. 따라서 1차적으로는 반드시 양쪽 피난계단을 통해 대피하며, 화염연기로 양쪽 계단 진입이 모두 불가능하거나 계단 이동이 불가한 긴급 상황에서만 휴게공간으로 대피하여 소방관의 구조를 대기한다.
4) 옥상(9층) 출입문 관리 : 본원의 9층 옥상은 주간 근무시간(09:00~18:00)에는 개방하며, 야간 및 근무시간 외에는 안전을 위해 당직자가 키로 시건 관리한다. 단, 화재 시 자동으로 잠금이 해제되는 비상문 자동개폐장치가 설치되어 있다.
5) 피난시설(인명구조기구) 위치 : 방열복 및 공기호흡기 2조는 1층 로비에 보관 비치한다.

다. 화재 시 직원의 업무분담은 자위소방대 조직 편성표를 따른다.

라. 층별 피난층 설정

위치	피난 층
2층~8층(일반적인 경우)	화재가 발생하지 않은 반대쪽 피난계단을 이용하여 지상1층(피난층) 외부로 대피한다.
2층~8층 (계단실 화염 차단 등 비상시)	화염 발생 층보다 높은 층: 피난계단을 이용하여 9층 옥상으로 대피한다. 화염 발생 층보다 낮은 층 : 피난계단을 이용하여 지상 1층 외부로 대피한다. 양쪽 계단 모두 진입 불가 시 : 각 층 스테이션 우측 [휴게공간(방화스크린 안쪽 공간)]으로 이동하여 연기를 차단하고 소방관 진입창을 통해 구조를 대기한다.
1층	주출입구 및 비상구를 이용하여 즉시 건물 외부로 대피한다.
지하층(B1~B4)	피난계단을 이용하여 지상 1층 외부로 대피한다.

마. 산소 등 의료가스의 안전한 보관 및 취급 방법

1) 산소 공급 설비 운영 : 본원은 산소발생기실의 의료용 산소발생기(메인)를 통해 중앙공급식으로 병동에 산소를 공급하며, 산소발생기 고장 등 비상시에 자동 전환 작동 되는 예비 산소탱크(40L)를 의료가스실에 안전하게 보관 관리한다.
2) 이동형 산소탱크 관리 : 병동 등 사용 부서에서 응급 및 이송용으로 사용하는 이동형 산소가스는 의료가스실에 보관하며, 사용이 종료되면 지정 보관장소(의료가스실 등)로 반납하여 관리한다.
3) 화재 발생시 피난유도반(또는 병동 근무자)은 각 병동(2~8층)에 설치된 산소 구역 차단밸브(Oxygen 밸브)의 커버를 제거하고 레버를 당겨 산소공급을 신속히 차단하여 화재 확산을 방지하며, 사용중인 이동형 산소탱크(10L)는 환자 대피 시 외부로 안전하게 반출시킨다.



화재 시 Oxygen 밸브의 커버를 제거 하고 레버를 당겨 산소를 차단시킨다.

바. 환자 유형별 대피

1) 환자 대피 우선순위

화재 발생 시 환자 대피는 환자의 이동 가능 정도와 위험도를 고려하여 C급 → B급 → A급 순으로 시행한다. 단, 화재 발생 위치, 연기 확산 정도, 환자 상태, 의료진 판단에 따라 현장 지휘자의 지시에 따라 조정할 수 있다.

구 분	환자 상태	대피 상태	대피 우선 순위
C급	독립보행이 가능한 환자	직원의 안내에 따라 피난계단을 이용하여 지상 1층(또는 안전구역)으로 이동	1순위
B급	약간의 도움으로 보행이 가능한 환자, 노약자	직원·간병사 또는 보호자의 부축을 받아 피난계단을 이용하여 안전구역으로 이동	2순위
A급	독립보행이 불가능한 환자, 침상 안정 환자, 휠체어 이용 환자	휠체어, 침대, 시트 끌기 등을 이용하여 우선 안전구획으로 수평이동 후 계단 대피 또는 구조 대기	3순위
검사·시술 중 환자	검사 또는 시술 중인 환자	의사의 판단에 따라 검사·시술을 중지하고 안전구획으로 이동	환자 상태에 따라 결정

2) 대피 유도 원칙

구 분	세부 내용
지휘체계	대피유도반은 환자를 유형별로 분류하고 대피 우선순위를 결정하여 지휘한다.
대피불가능자 관리	대피 불가능자 또는 고위험 환자 명단을 사전에 확인하고, 화재 발생 시 우선 지원한다.
인력편성	개인행동을 자제하고 2인 이상 조를 편성하여 대피를 유도한다.
질서 유지	환자와 보호자가 당황하지 않도록 반복적으로 안내하며, 소리를 지르거나 뛰지 않도록 유도한다.
분산 대피	특정 장소에 대피자가 집중되지 않도록 안전구획별로 분산 대피시킨다.

3) 후송 계획

구분	내용
후송 대상	화재로 인한 손상 환자, 화상 환자, 연기 흡입 환자, 원내 치료가 어려운 환자
후송 우선순위	1순위: 거동이 불편한 중증환자 / 2순위: 노약자 / 3순위: 보호가 필요한 환자 / 4순위: 일반 환자 및 보호자 / 5순위: 직원
후송 방법	119 및 응급의료정보센터의 안내에 따라 후송 가능 의료기관을 확인한 후 이송한다.
후송 병원	인근 응급의료기관을 우선 고려하되, 최종 후송병원은 119 또는 응급의료정보센터 안내에 따른다.
의료기구	중증환자 후송 시 필요한 산소, 수액, 의료기구 등은 환자 상태에 따라 함께 후송한다.

6. 소방시설·장비의 종류 및 사용 방법

가. 소방시설의 종류

1) 소화설비

가) 소화기구 : ABC분말 소화기, K급 소화기, Co2 소화기, 하론 소화기

나) 옥내소화전 : 소방호스(40mm) 2본, 관창(노즐 또는 직문사형 겸용)

다) 스프링클러(바닥면적 600m² 이상) : 헤드, 자동경보밸브, 시험밸브

2) 경보설비 : 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 비상경보, 자동화재속보 설비

3) 피난구조설비

가) 피난유도등 : 대형피난구 유도등 및 통로 유도등, 비상조명 등등

나) 인명구조장비 : 방열복, 공기호흡기

4) 소화용수설비 : 저수조, 상수도 설비

5) 소화활동상 필요한 설비(연결송수관설비)

나. 소방시설(기구) 사용 요령

1) 소화기 사용법

가) P : pull 안전핀을 뽑고 (pull the pin)

나) A : aim 호스는 화점을 향하여 (aim near the base of the fire)

다) S : squeeze 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 (squeeze the handle)

라) S : sweep 쓸어낸다. (sweep at the base of the fire)

2) 소화기 보관요령

가) 넘어지지 않게 안전한 장소에 둔다.

나) 소화기 상부에 어떠한 물건도 올려놓지 않는다.

다) 안전핀이 빠지거나 약제가 방사된 흔적이 보이거나 압력계기의 눈금이 녹색을 가리키고 있는지 확인한다.

3) 소화전 사용법 및 사용 시 주의사항(2인 1조 – A, B로 지칭)

가) A는 소화전을 열어 노즐을 양손으로 꼭 잡고 호스를 빼내어 발화 지점까지 간다.

나) B는 A가 신호를 보내거나 발화지점을 도착 했을 때 밸브를 개방하여 물을 튼다.

다) A는 호스 앞부분을 조절하여 발화지점에 물을 분사한다.

4) 알람밸브 : 작동은 자동이며 필요시에는 주 밸브를 잠근 후 퇴수 밸브를 개방한다.

5) 비상벨 : 화재 발신기(적색) 아크릴 판의, 누름 스위치(버튼)를 세게 누른다.

7. 금연 관리

가. 금연 구역 지정 및 관리

1) 본원의 모든 시설내부는 금연 구역이다.

가) 관련근거

① 「국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)」

② 「국민건강증진법 시행규칙 제6조(금연구역 등)」

③ 「의료법 제3조(의료기관)」

나) 건물 내부와 금연을 위해 필요한 구역에는 금연표지 또는 금연 스티커를 부착한다.

다) 병동 간호사는 환자 및 보호자 입원시 입원생활 안내물을 통해 금연관련 교육을 시행하고 직원은 연1회 금연교육을 받는다.

라) 직원의 금연교육 방법은 9.2 직원교육 규정을 따른다.

나. 흡연실(실외) 설치 관리

1) 설치 위치 : 흡연 구역은 정문 출입구로부터 좌측 30m지점을 실외흡연구역으로 지정한다.
2) 환자 및 보호자 및 내원객에게 흡연구역 위치를 안내하고 흡연구역 표지를 부착한다.
3) 흡연구역은 담배꽁초로 인한 화재 예방을 위해 방화사(모래)를 비치하고 청결 안전 상태를 일상 점검한다.

다. 금연구역 내 흡연자에 대한 조치

1) 직원은 병원 건물 내부에서 흡연자를 발견 시 즉시 제지하고, 병원 입구 좌측 30m 실외흡연구역을 안내하며 법령에 따른 과태료 부과 대상임을 고지한다.
2) 직원이 금연 구역 내에서 흡연을 하여 적발될 경우, 이를 발견한 직원은소속 부서장에게 통보하고 부서장은 흡연직원에게 경고 및 징계조치를 할 수 있다.
3) 금연구역에서 환자가 흡연 시 1차 경고하고, 계속 흡연 시 강제 퇴원 조치할 수 있음을 고지한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 소방안전관리일지
2. 소화기 관리대장
3. 자위소방대 조직 편성표
4. 소방 교육·훈련 평가표
5. 화재발생시 행동요령
6. 화재대피유형명단
7. 소화기 점검표
8. 화재대피 안내도
9. 소화전 점검표
10. 화재안전관리 활동계획서
11. 흡연자 발생 시 보고절차
12. 금연구역 내 흡연 보고서
13. 원내 금연 경고문 / 흡연구역
14. 금연관련 법률

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

NATURE 네이처 요양병원

부록1. 소방안전관리일지

20 년도 소방안전관리일지

(양호:O. 불량:x. 정비요:△)

결재	담당	부서장	병원장

점검항목	세부항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
소방시설 유지관리	·소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ·수신기 및 밸브류는 정상인지 여부 ·유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부 ·스프링클러 펌프실 전기류 정상여부																															
피난방화시설 유지관리	·소화전 주위 장애물 적치 여부 ·계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ·방화문 주위 장애물 적치 여부 ·비상문 자동 개폐장치 정상인지 여부																															
화재예방조치	·가연물 및 위험물 사용 적정 여부 ·전기사용 적정 여부(문어발식 사용금지) ·가스시설 적정 여부 ·가스누설경보기 작동 여부																															
화기취급감독	·화기취급 상태의 적정 여부 -이동식 난로 / 버너 -전열기구 -공사 중 소화기 비치																															
기 타	·방화환경표시(주의, 경고, 금연표시)																															
점검자서명																																

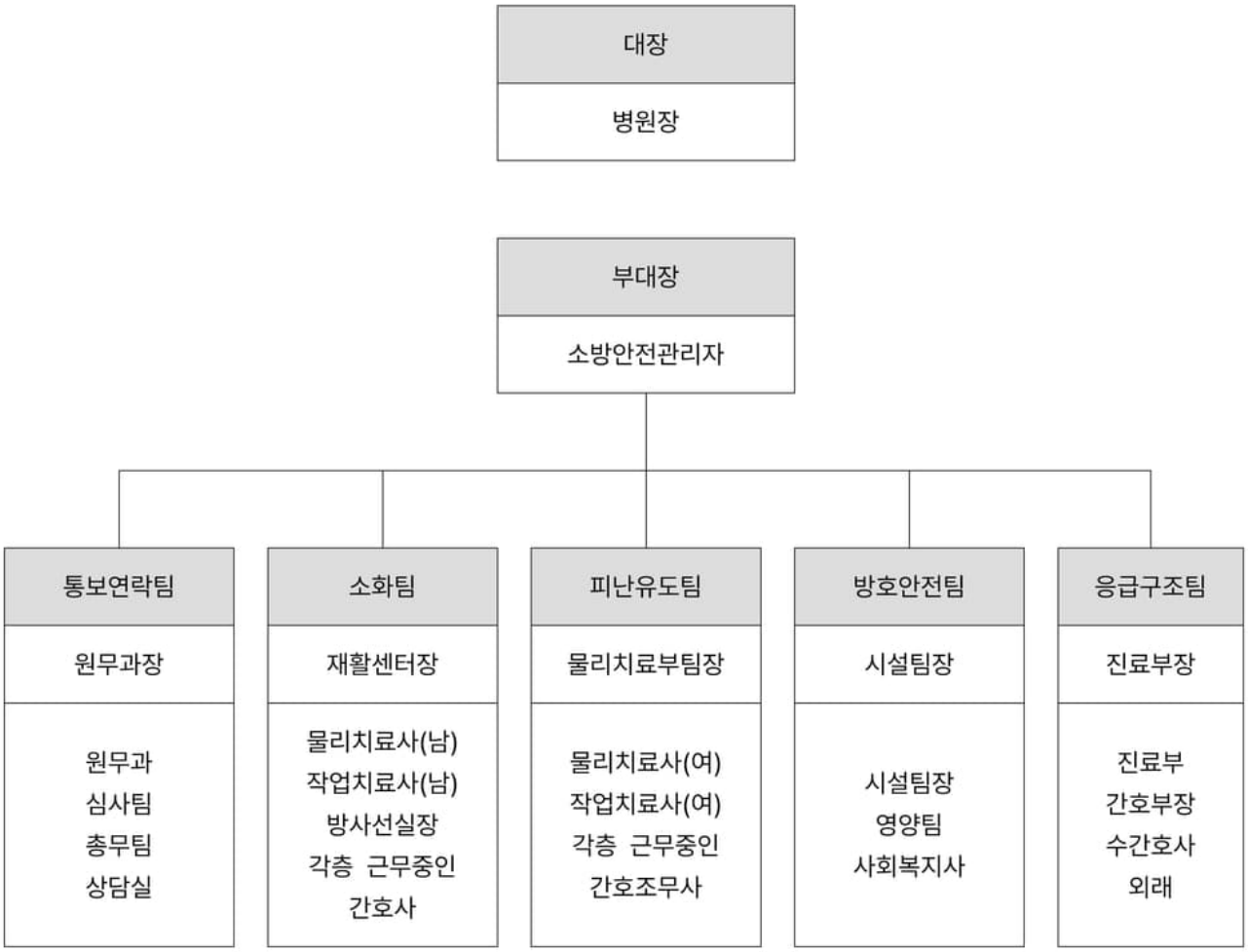
부록2. 소화기관리대장

소화기 관리대장(수동식분말ABC 3.3KG N_2, 축압식, 철제) 1-1

층별	자체관리번호	설치위치	소화기종류	점검자 1월 일	점검자 2월 일	점검자 3월 일	점검자 4월 일	점검자 5월 일	점검자 6월 일	점검자 7월 일	점검자 8월 일	점검자 9월 일	점검자 10월 일	점검자 11월 일	점검자 12월 일

부록3. 자위소방대 조직 편성표

네이처요양병원 자위 소방대 조직도



◈① 임무자는 통보연락 후 방화문 폐쇄하고 피난 유도 팀에 합류 할 것

◈화재 발생 시에는"불이야~"큰소리로 외치고,
주위에 전파 후 내선900 / 원무과 또는 소방서 119에 신고한다.

◈화재 신고 연락을 받은 원무과는 구내방송으로 "코드레드 ( )병동 ( )호실 2회" 멘트 방송한다.

◈화재는 초기진압(3분 이내)이 매우 중요합니다.
각 병동에 비치된 소화기 위치를 미리 확인해두며, 화재 시에 사용하여 불을 끕시다.

◈본인에 속한 팀 업무를 잘 숙지하고, 임무가 끝나면 다른 팀에 투입한다.

〈자위소방대 : 휴일/야간〉

휴일 / 야간

당직 의사

통보연락팀 · 소화팀	피난유도팀 · 응급구조팀
1. 휴일(D) : 원무과 당직자 2. 야간(N) : 원무과 당직자 3. 병동 근무자 (최초 발견자 전파 및 소화진압)	1. 당직 의사 2. 병동 간호, 보호사근무자 3. 영양실 (D)근무자
팀 임무	**팀 임무**
1. 화재발생 안내방송 2. 119에 화재신고 3. 화재발생장소 근무자 소화기 및 옥내소화전이용 초기진압 4. 직원 비상연락망에 의거 전화연락 통보 5. 임무를 마치면 화재 현장으로 출동	1. 출입구 개방 2. 대피안내에 따라 신속히 양쪽 계단을 이용하여 지상 또는 옥상으로 환자 대피 3. 화재구역 방화문 폐쇄 및 출입자 통제 4. 엘리베이터 탑승 저지 5. 환자 응급 처치 및 이송 6. 주요 문서 반출

부록4. 소방 교육•훈련 평가표

네이처 요양병원

소방교육·훈련 평가보고서

담당자	원무과장	행정부장	병원장

1. 교육·훈련 개요

교육·훈련명		교육구분	
교육일시		교육장소	
교육대상		참석인원	
교육실시자		주관부서	
작성부서		작성자	

2. 교육·훈련 내용

주요 내용

3. 평가 결과

평가구분	
평가의견	
미흡사항	
개선조치	

4. 미흡사항 및 개선조치

미흡사항	개선조치	담당자	완료일/예정일

※ 미흡사항이 없을 경우 "해당 없음"으로 기록한다.

5. 종합의견

6. 교육 및 훈련 사진

부록5. 화재발생시행동요령

화 재 발 생 시 행 동 요 령

" 불이야 " 를 큰 소리로 세 번 외치고
각 층의 양쪽 계단에 설치된 소화전의 화재경보기를
누르고 소화기 및 옥내 소화전을 이용하여 자위소방대가
도착할 때 까지 초기 진압하고 제2전파자가 즉시
(원내전화 900/소방서 119)에 신고한다.

분 류	환자 유형의 정의	대 피 계 획
A 급 환 자	중 환 자 , 독 립 보 행 이 어려운 환자	필요 시 의사 또는 간호인력이 동행하고 대피 유도원 도움으로 대피 한다.
B 급 환 자	약간의 도움으로 보행이 가능한 환자	간호인력 또는 대피 유도원 도움으로 대피 한다.
C 급 환 자	독립 보행이 가능한 환자	간호 인력 또는 대피 유도원 도움 및 자력으로 대피 한다.

화재 발생 시 대피 우선순위 순서

(C 급 ⇒ B 급 ⇒ A 급) 에 따라 대피유도

네이처요양병원
NATURE HOSPITAL

화재 대피 유형 명단

○○병동

대피우선순위(C급→B급→A급)

C급 환자		B급 환자		A급 환자	
독립보행이 가능		약간의 도움으로 보행이 가능		중환자, 독립보행이 어려움	
호실	이름	호실	이름	호실	이름

부록7. 소화기 점검표

소 화 기 점 검 표

점검년도	20 년	설치장소	
관리번호		종 류	

점검월일	점검자	점검결과
1/		
2/		
3/		
4/		
5/		
6/		
7/		
8/		
9/		
10/		
11/		
12/		
점검항목	본체용기 / 레버등(손상, 부식) / 호스 및 노즐 안전핀 봉인 / 지시압력계(압력상태), 소화약제 **○:양호 ✖:불량 △:보수**	

※ 직사광선이 들지 않는 장소로 용기가 철재이므로 습기가 없는 장소에 보관되어 있는지 확인한다.
압력게이지가 초록색 정상범위(7kg/m²~9.8kg/m²)에 있는지 확인한다.
매월 1회 점검을 원칙으로 하며 중량을 측정하거나 들어보아서 소화약제가 차 있는지 확인한다.
6개월에 1번 정도 뒤집어 약제의 경화를 방지한다. 봉인줄 및 안전핀이 파손되거나 분실되었는지 점검한다.
철제로 만들어진 용기는 접합부위에 녹이 슬어있는지 확인하고 부식이 심한용기는 폐기한다.

부록8. 화재대피 안내도

피난안내도 EVACUATION DIAGRAM

네이처요양병원 1F

화재 시 피난요령
HOW TO EVACUATE IN CASE OF FIRE

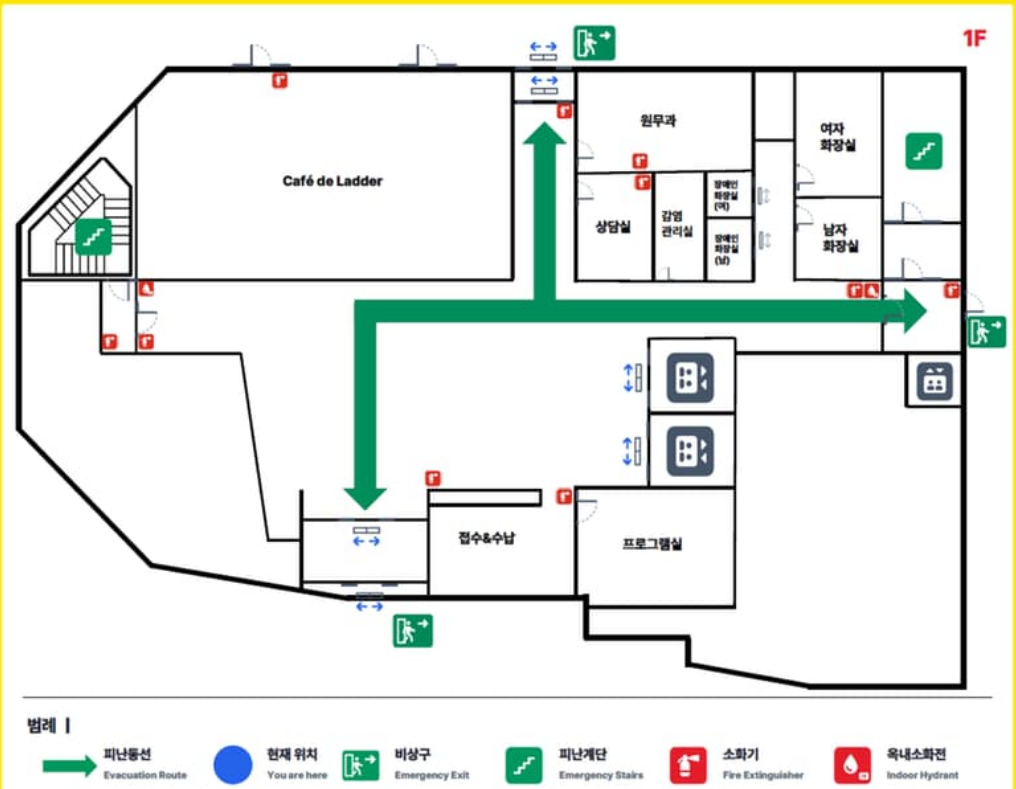
1. 주변에 '불이야!'라고 알린다.
   Shout "Fire!" to alert others.
2. 발신기를 누르고 119에 신고한다.
   Activate the alarm and call 119.
3. 자세를 낮추고 유도등을 따른다.
   Stay low and follow exit signs.
4. 엘리베이터 대신 계단으로 대피한다.
   Do not use elevators. Use the stairs.

환자·보행약자는 직원 안내에 따라 우선 대피

소화기 사용요령
HOW TO USE A FIRE EXTINGUISHER

1. 안전핀을 뽑는다.
   Pull the safety pin.
2. 노즐을 불의 아랫부분으로 향한다.
   Aim at the base of the fire.
3. 손잡이를 쥐고 골고루 분사한다.
   Squeeze the handle and sweep.

불길·연기가 크면 초기소화보다 대피가 우선입니다.



부록9. 소화전 점검표

소화전 점검표

	점검사항	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
옥내/외 소화전 설비	1. 소화전 위치표시등의 정상적인 점등 여부												
	2. 가입송수장치가 자동 및 수동으로 작동하는지 여부												
	3. 소화전 주위의 장애물 등은 제거 되어 있는가												
	4. 수원의 정량 확보 및 개폐밸브의 개방 여부												
	5. 배관 및 밸브류 등은 부식 및 누수가 없는가												
	6. 소화전내 호스 및 관창의 비치 유무												
	7. 수원 및 배관주위의 동파 위험 여부는 없는가												
점검자 확인													

#매월 첫 번째 주 월요일 점검한다.

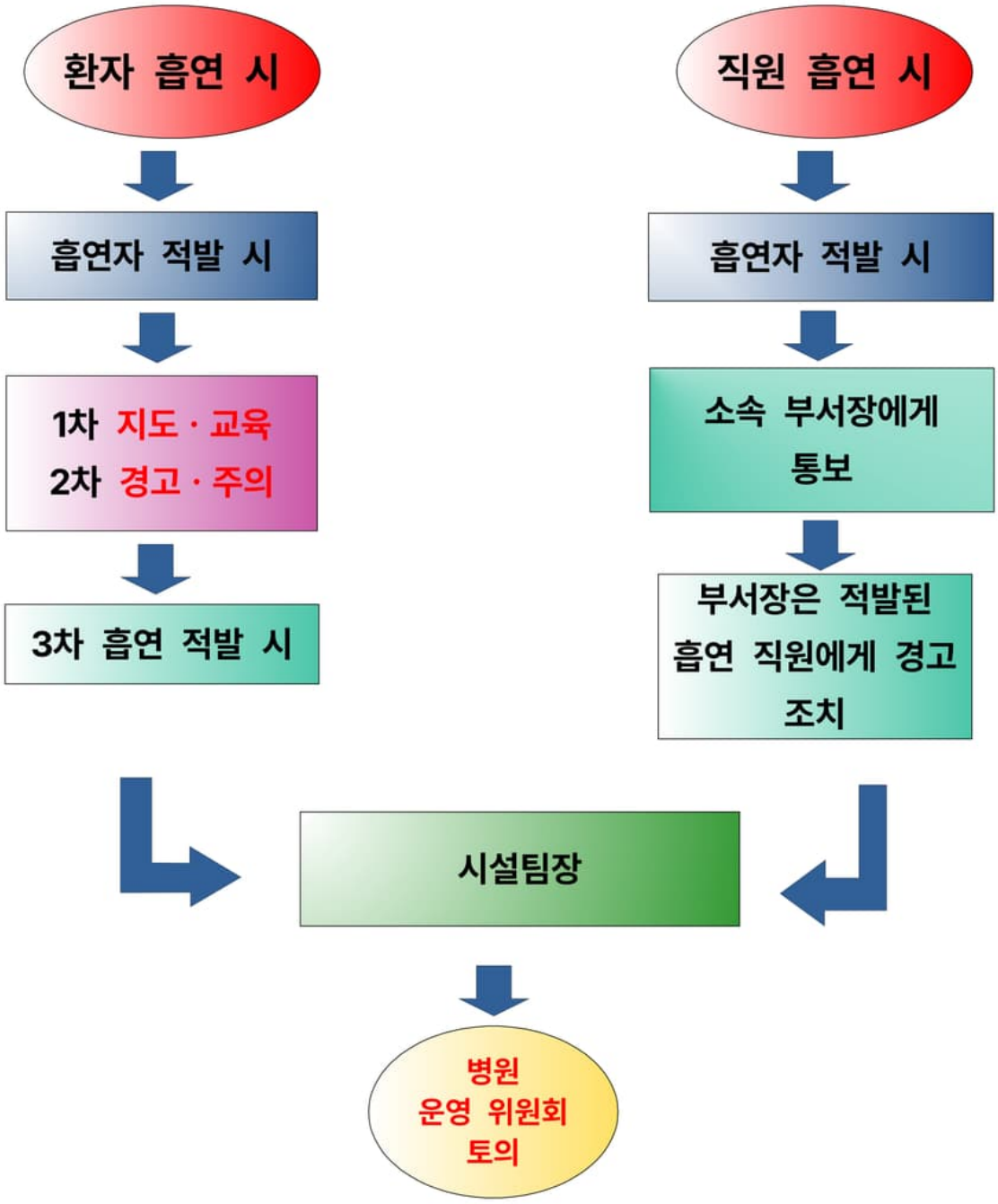
20 년 화재안전관리 활동계획서

결재	담 당	부서장	병원장

구 분 (정기점검)		20 (시기)													비고
		담당자	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	예산	
일상예방점검	소화기, 소화전															
	비상구와 비상계단															
	유도등 및 유도 표지판															
	화재수신반의 작동기능															
	발신기, 비상콘센트, 감지기															
	방화문, 저수조															
	소화전펌프 제반설비 기능															
정기점검	작동기능점검															
	종합정밀점검															
소방안전환경조성	불조심 현수막 게시															
	병원 내에 금연구역 안내문 게시															
직원교육	소방교육															
	금연교육															
합 계																

부록11. 흡연자 발생 시 보고절차

◆흡연자 발생 시 보고절차◆



부록12. 금연구역 내 흡연 보고서

금연구역 내 흡연 보고서

결재	담당자	부서장	병원장

발견일시	년 월 일		발견 장소			
발견자	소속		직위		입사일	
	성명		성별	□남 / □여	나이	
흡연자	소속		직위		입사일	
	성명		성별	□남 / □여	나이	
처리내용						

위와 같이 보고합니다.

년 월 일

부서명

보고자 (서명)

●원내 금연 경고문●


금연
구역
반갑습니다
본 병원은 보건복지부 법령에 의한 금연건물입니다.
흡연장소는 1층 후문 주차장 흡연구역과
옥상 출입구에서 10미터 떨어진 곳에서만 흡연가능합니다.


흡연구역

부록 14. 금연관련 법률

국민건강증진법 제9조, 의료법 제3조

국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)

④ 다음 각 호의 공중이 이용하는 시설의 소유자·점유자 또는 관리자는 해당 시설의 전체를 금연구역으로 지정하고 금연구역을 알리는 표지를 설치하여야 한다. 이 경우 흡연자를 위한 흡연실을 설치할 수 있으며, 금연구역을 알리는 표지와 흡연실을 설치하는 기준·방법 등은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2011. 6. 7., 2016. 12. 2., 2020. 12. 29.> (1~7호 생략)

8. 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 (9~26호 및 제5항~제6항 생략)

⑦ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다. <신설 2010. 5. 27., 2016. 5. 29.>

⑧ 누구든지 제4항부터 제7항까지의 규정에 따라 지정된 금연구역에서 흡연하여서는 아니 된다. <개정 2010. 5. 27., 2016. 5. 29., 2017. 12. 30.>

의료법 제3조(의료기관)

① 이 법에서 "의료기관"이란 의료인이 공중(公衆) 또는 특정 다수인을 위하여 의료·조산의업(이하 "의료업"이라 한다)을 하는 곳을 말한다.

② 의료기관은 다음 각 호와 같이 구분한다. <개정 2009. 1. 30., 2011. 6. 7., 2019. 4. 23., 2020. 3. 4.> (1~2호 생략)

3. 병원급 의료기관: 의사, 치과의사 또는 한의사가 주로 입원환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관으로서 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 병원

나. 치과병원

다. 한방병원

라. 요양병원(「장애인복지법」 제58조제1항제4호에 따른 의료재활시설로서 제3조의2의 요건을 갖춘 의료기관을 포함한다. 이하 같다)

마. 정신병원

바. 종합병원